EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 88116
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-07-08 11:28:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: GONZALO PATRICIO BRAVO FERRADA			**RUN**	: 11.809.307-0
F.Nac	: 19-07-1971	**Edad**	: 52 AÑOS, 11 MESES	**Género**	: Masculino
Dirección	: NINQUIHUE STA ROSA ACT			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-07-06	**Fecha Egreso**	: 2024-07-08 11:28:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. K92.2-HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Hemorragia Digestiva
Cirrosis hepatica Alcoholica descompensada
--> MELD Na: 19 pts | CHILD C | ACLF/CLIFF: 37 ptos
--> HTP Clinicamente significativa + Varices ligadas
--> Encefalopatia G0
--> Hepatectomia VI + Gastrectomia total + Esplenectomia (2021)
. Anemia de enfermedades cronicas
. Diskalemias resueltas
. HTA
. Desnutrición Mixta Severa
. Dependencia moderada

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. K92.2-HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente masculino adulto semidependiente, con antecedentes de DHC x OH, HTA, DM NO IR, Varices esofágicas (en registros no ligables), op. de gastrectomia total, esofagectomia distal y esplegnectomía debido a Cirrosis hepatica complicada con hipertensión portal. Con habito alcoholico activo, con hospitalización reciente el 12/06 debido a neumonía, dado de alta el 03/07 con HODOM para completar tto antibiótico: Rifaximina 200 c/8 horas vo x 14 dias Acido ursodesoxicolico 250 mg c/12 horas x 30 dias, Lactulosa 40cc c/8 horas vo, ferranim 1 capsula c/12 horas vo, Acido folico 1 comprimido c/dia vo, Furosemida 40mg c/dia vo, Espironolactona 25mg c/8 horas vo, Carvedilol 6.25mg 1/2 comprimido vo, Ciprofloxacino 500mg 1 c/12 horas x 14 dias, Slow K 600mg 2 comp c/8 horas vo x 5 dias.
es traído por M1 desde domicilio debido a presentar hematemesis en reiteradas oportunidades indica familiar de aproximadamente 9 de abundante cuantía. Familiar indica que se encuentra postrado desde entonces. Al ingreso en malas condiciones generales con ictericia generalizada en escleras y en piel, ingresa tendiente a la hipotensión glicemias limites, normocardico subfebril, enflaquecido.
Exámenes CREA 0.5 Bilirrubina Indirecta : 5,33 mg/dL Bilirrubina Directa : 14,17 mg/dL Bilirrubina Total : 19,50 mg/dL Lactato : 3,1 mmol/L Proteina C Reactiva : 63,4 mg/L Potasio (K) : 3,00 mmol/L Cloro (Cl) : 107,00 mmol/L Hemoglobina : 6,1 g/dl Hematocrito : 17,6 o/o Recuento de leucocitos : 12,40 mil/ul Plaquetas : 40 mil/ul pH : 7,60
Es evaluado por Residente UTI Paciente ya con indicación de AET, no RCP, no UPC por no beneficiarse de manejo en unidad crítica. Hospitalizar en sala basica. AET. Favorecer acompañamiento familiar.
Se ingresa la servicio mara manejo al ingresio al servicio de medicina p en regulares a malas condiciones enflaquecido, piel y escleras con ictericia , mucosas hidratadas, yugularas planas, torax

expansible sin agregados, rr2ts, mp + sra, abdomen bd con ascitis leve a moderada. Glasgow 14 puntos.
Paciente Sin Sangrado Activo Desde hace 48 Horas, Vigil Orientado, Piel Y Mucosa Ictéricas , Eeii Edema +++, Se Conversa Con Famialres Se Decide Alta Médica Con Hodom Posterior A Transfusión.

PLAN DE MANEJO:

Reposo relativo asistido
Regimen liviano hiposodico, hiperproteico
Hidratacion oral, maximo 1000cc al dia
No OH, no AINES, no Cremas cosmeticas
Rifaximina 200 c/8 horas vo x 14 dias
Acido ursodesoxicolico 250 mg c/12 horas x 30 dias
Lactulosa 40cc c/8 horas vo
PEG 1 sobre diluido en 250cc de agua c/ 12 horas vo, suspender cuando hayan mas de 2 depocisiones diarias
Espercil Comp 250 Mg 1 Comp Cada 12 Horas Por 5 Dias
Konakion 1 amp dia ev Por 5 Dias
ferranim 1 capsula c/12 horas vo
Acido folico 1 comprimido c/dia vo
Furosemida 40mg c/dia vo
Espironolactona 25mg c/8 horas vo
Carvedilol 6.25mg 1/2 comprimido vo
Ciprofloxacino 500mg 1 c/12 horas x 14 dias
Metamizol 300mg 1 c/8 horas SOS dolor
Slow K 600mg 2 comp c/8 horas vo x 5 dias
Continuar KTM 1 vez al dia en HODOM
Continuar Curaciones de LPP en HODOM
Vigilar Condicion clinica de paciente en visita
Reconsultar SOS signos de alarma
Retomar controles en Consultorio de origen

INDICACIONES AL ALTA

1. - Seguimiento por HODOM + KTM + Curacion de LPP sacra . TTO EV
2. - ATB profilaxis por inmunosupresion secundaria a Cirrosis OH + Esplenectomia,
3. - manejo en contexto de cirrosis hepatica

EXÁMENES Y RESULTADOS

Creatinina : 0,80 mg/dl 0,66 - 1,25 Clearence Calculado(MDRD) : 101,12 Proteina C Reactiva : 79,9
Uremia : 49 Sodio (Na) : 132,00 * mmol/L Potasio (K) : 3,20 * mmol/L
Cloro (Cl) : 102,00
leucocitos : 17,90 * mil/ul Recuento Hematies : 2,06 * Mill/ul Hematocrito : 19,9 * o/o Hemoglobina : 6,8 * g/dl Plaquetas : 53 *

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO